Lo shock improvviso

Danno psichico nella negligence in Inghilterra e Galles. Il requisito storico dello shock, Sion e Ronayne, e la correzione introdotta da Paul [2024] UKSC 1.

1. Leggere le vecchie espressioni nel loro contesto

Le decisioni più antiche descrivevano spesso la patologia della vittima secondaria come effetto del **nervous shock**: una reazione brusca alla vista o al suono di un evento angosciante che coinvolgeva una persona cara. I giudici lo distinguevano dall'ansia accumulata assistendo al progressivo peggioramento di un familiare.

In Alcock v Chief Constable of South Yorkshire Police [1992] 1 AC 310, Lord Ackner descrisse lo shock come improvvisa percezione di un evento orribile che scuote violentemente la mente. Decisioni successive trasformarono quel linguaggio in una restrizione giuridica autonoma. È importante per capire i vecchi casi, ma non rappresenta interamente il diritto dopo il 2024. [1]

> **Regola attuale:** Paul v Royal Wolverhampton NHS Trust [2024] UKSC 1 ha respinto l'ulteriore requisito dello "shock improvviso al sistema nervoso" e il test separato secondo cui l'evento dovrebbe essere sufficientemente "orribile". Nessuno dei due va presentato come condizione aggiuntiva attuale. [1, parr. 71-78]

2. Che cosa resta necessario?

La domanda relativa a una patologia psichiatrica richiede ancora una malattia riconosciuta dalla medicina e il nesso causale con la violazione del dovere. Dolore, paura o turbamento ordinario non bastano. La sofferenza del familiare non prova automaticamente una diagnosi: va dimostrata la patologia di chi agisce.

Nella categoria riconosciuta degli incidenti si applicano ancora dovere e prevedibilità, oltre ai **controlli di Alcock**: stretti legami di amore e affetto; vicinanza nel tempo e nello spazio all'incidente o alle conseguenze immediate; percezione diretta e non semplice ricezione di notizie. [1]

3. Tre domande da non confondere

Medica: Quale patologia ha chi agisce? **Causale:** Quale esperienza l'ha provocata? **Giuridica:** Il convenuto ha verso questa persona il dovere pertinente? Una patologia può essere reale anche se la domanda viene respinta. La comprensione umana non prova malattia o responsabilità.

La guida riguarda le vittime secondarie. Non applica ogni limite degli incidenti a tutti i contesti, per esempio alla domanda personale di un lavoratore per stress professionale.

I precedenti casi medici

4. Sion v Hampstead Health Authority (1994)

Fatti: Un giovane fu ferito in un incidente motociclistico e ricoverato. Il padre rimase al suo capezzale per quattordici giorni, assistendo al peggioramento, al coma e alla morte. Sosteneva che l'ospedale non avesse diagnosticato per negligenza una persistente emorragia interna, causando il decesso e la sua stessa patologia psichiatrica.

Chi era il convenuto? L'autorità ospedaliera, non il responsabile dell'incidente stradale. La domanda riguardava l'esperienza del padre relativa al trattamento e al deterioramento in ospedale. Non va descritta come una domanda fondata sull'aver visto la collisione iniziale.

Esito: La domanda fu eliminata in via preliminare e la Court of Appeal confermò. Applicando il requisito allora utilizzato, ritenne che la patologia derivasse da un processo graduale, non da un evento improvvisamente sconvolgente; al momento del decesso, la morte era attesa. La negligenza allegata era assunta ai fini di tale valutazione, non provata al termine di un processo completo. [1, parr. 62-63]

5. Liverpool Women's Hospital NHS Foundation Trust v Ronayne

Caso: [2015] EWCA Civ 588. La negligenza durante l'intervento della signora Ronayne causò una grave malattia e cure d'urgenza. Il marito la vide collegata a macchinari prima di un nuovo intervento e poi incosciente, ventilata e molto gonfia. Dopo una lunga permanenza in terapia intensiva, la donna si riprese.

Diagnosi: Il marito sosteneva di avere PTSD. Il giudice di primo grado respinse questa diagnosi ma riconobbe una patologia psichiatrica, trattata in appello come disturbo dell'adattamento. Non si può quindi dire che il PTSD fosse provato solo perché la trascrizione lo afferma.

Esito: Il marito vinse inizialmente, ma l'ospedale ottenne l'accoglimento dell'appello e la domanda fu respinta. La Court of Appeal applicò il vecchio approccio dello shock improvviso e dell'evento orribile. Considerò l'esperienza una sequenza di episodi angoscianti e dubitò dell'analisi causale. [2]

Come usarli oggi: Spiegare la decisione storica e poi Paul. Il ragionamento sullo shock non è un test autonomo attuale; eliminarlo non rovescia automaticamente gli esiti né prova gli altri requisiti.

La situazione dopo Paul

6. Paul: causalità senza un ulteriore meccanismo di shock

L’11 gennaio 2024 la Supreme Court chiarì che le osservazioni sullo shock in Alcock non stabilivano un’ulteriore restrizione. Non occorre dimostrare un particolare meccanismo neurologico o psicologico attraverso cui la percezione dell’incidente ha causato la patologia. Il nesso causale stesso resta da provare. [1, parr. 73-74]

La Corte respinse anche una soglia separata relativa a quanto l’evento fosse “orribile”. Questa è diversa dalla prevedibilità ragionevole della patologia psichiatrica nella posizione di chi agisce. Eliminare il test aggiuntivo non elimina la prevedibilità. [1, parr. 75-78]

7. Diagnosi tardiva e accumulo graduale sono diversi

Esempio inventato A: Una madre vede una collisione negligente in cui suo figlio è gravemente ferito. I sintomi compaiono dopo e la diagnosi arriva mesi più tardi. Il ritardo della diagnosi non esclude di per sé la domanda. Occorre provare patologia riconosciuta, causalità e tutti gli altri requisiti.

Esempio inventato B: Un familiare si ammala visitando ripetutamente un paziente la cui malattia peggiora per settimane. Eliminare lo shock non rende la domanda automaticamente accoglibile. Restano da esaminare dovere, limiti fondati sugli incidenti e altre condizioni.

> **Distinguere:** quando è avvenuto l’incidente; quando è stato percepito, insieme alle conseguenze immediate; come si è sviluppata la patologia; quando è stata diagnosticata. La diagnosi non deve essere formulata sul luogo dell’incidente.

8. Perché i familiari in Paul persero comunque?

La Supreme Court respinse i ricorsi in Paul, Polmear e Purchase. La maggioranza rifiutò di estendere l’eccezione fondata sugli incidenti all’assistere alle crisi mediche o morti per malattia considerate, dopo precedenti negligenze diagnostiche o terapeutiche. In quelle circostanze il dovere verso il paziente non comprendeva tale protezione dei familiari. [1]

La questione è l’ambito del dovere, non l’autenticità delle patologie. Non significa neppure che la negligenza medica non possa mai comportare un incidente. Nel trattare Sion e Ronayne bisogna quindi separare il vecchio ragionamento sullo shock dall’odierna analisi del dovere.

Metodo d’esame: Identificare il vecchio ragionamento, spiegare la correzione di Paul e poi verificare patologia, causalità, prevedibilità, incidente rilevante e controlli di Alcock.

Verifica la comprensione

1. Lo shock improvviso è un requisito aggiuntivo attuale per le vittime secondarie?
Risposta: No. Paul ha respinto l'autonomo requisito dello "shock improvviso al sistema nervoso".

2. Paul ha eliminato patologia riconosciuta e causalità?
Risposta: No. Entrambe restano necessarie nella domanda per una patologia psichiatrica.

3. Chi era convenuto in Sion?
Risposta: L'autorità ospedaliera. Si contestavano cure negligenti dopo l'incidente motociclistico, non la guida negligente di quel convenuto.

4. Quale fu l'esito di Ronayne?
Risposta: Il marito vinse in primo grado ma perse dopo l'appello dell'ospedale. Il PTSD fu escluso; in appello si considerò un disturbo dell'adattamento.

5. Oggi occorre dimostrare che l'evento fosse separatamente abbastanza "orribile"?
Risposta: No. Paul ha respinto tale test. La prevedibilità ragionevole della patologia resta rilevante.

6. Una diagnosi formulata mesi dopo esclude necessariamente la domanda?
Risposta: No. Momento della diagnosi e nesso causale con l'incidente sono questioni diverse. Restano tutti gli altri requisiti.

7. Eliminare lo shock fece vincere i familiari in Paul?
Risposta: No. I ricorsi furono respinti per l'ambito del dovere e i limiti dell'eccezione fondata sugli incidenti.

La lezione centrale

Storicamente: i giudici richiedevano spesso un evento improvvisamente sconvolgente o orribile. **Dopo Paul:** questi test aggiuntivi sono respinti; restano patologia, causalità, prevedibilità e i limiti riconosciuti ai doveri verso le vittime secondarie.

Fonti e approfondimenti

[1] *Paul v Royal Wolverhampton NHS Trust; Polmear v Royal Cornwall Hospitals NHS Trust; Purchase v Ahmed* [2024] UKSC 1: parr. 62-63 (Sion), 69-78 (Ronayne e i test respinti), 138-143 (dovere medico ed esito). Vi è discusso anche *Alcock* [1992] 1 AC 310. Sentenza della Supreme Court.

[2] *Liverpool Women's Hospital NHS Foundation Trust v Ronayne* [2015] EWCA Civ 588, soprattutto parr. 1-9 e 38-48. Sentenza della Court of Appeal, The National Archives. *Sion v Hampstead Health Authority* [1994] 5 Med LR 170 è discusso in [1].